Apport de l'électroencéphalogramme dans le diagnostic des épilepsies de l'enfant à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso.

Nom du présentateur : Ouédraogo Pingdéwendé Victor

Auteurs et coauteurs : **Ouédraogo Pingdéwendé Victor**, Savadogo Abdoul Aziz, Semporé W Yves, Millogo Athanase

Affiliations : Université Nazi Boni, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction

- Épilepsie fréquente au Burkina Faso.
- Prévalence environ 10,6 pour 1 000 habitants.
- Pathologie sous-diagnostiquée en raison des considérations socio-culturelles.
- Cependant, augmentation de l'accessibilité à la médecine moderne renforcement de la prise en charge de l'épilepsie.

Introduction

Electroencéphalogramme (EEG) :

- Examen simple et non douloureux.
- Mesure l'activité électrique du cerveau grâce à des électrodes placées sur des régions précises du crâne.
- Enregistre une anomalie de l'activité cérébrale pour confirmer le diagnostic de l'épilepsie, en indiquant un foyer ou un syndrome.

Objectif

Étudier la contribution de l'EEG dans le diagnostic des épilepsies de l'enfant.

Matériel et méthode(s)

- Étude observationnelle
- Type transversal
- Visée analytique
- Collecte rétrospective
- Site : Centre médical privé à Bobo-Dioulasso

Matériel et méthode(s)

- Inclusion : tous les patients âgés de moins de 18 ans.
- EEG réalisé durant la période du 1er juin 2018 au 30 mai 2020.
- Données recueillies grâce à une fiche de compilation afin de collecter les informations dans les registres cliniques.

Matériel et méthode(s)

- Données saisies dans le logiciel Microsoft Office Excel 2016 et analysées par le logiciel Epi Info 7.2.2.6.
- Fréquences calculées pour les variables qualitatives.
- Moyenne et l'écart-type calculés pour les variables quantitatives.
- Facteurs associés déterminés par la régression logistique.

Matériel et méthode(s)

- Anonymat des malades préservé
- Fiches de report de cas ne comportant d'identités.
- Recueil et vérification des fiches par un médecin tenu au secret médical.

Résultats

- Au total, 124 enfants inclus.
- Moyenne d'âge: 9,1 ans ± 4,4.
- Sex-ratio 1,25.
- Demandeurs d'EEG : médecins spécialistes 51,6 %.

  Types d'EEG : veille 55,6 % ; sommeil 44,4 %.

Résultats

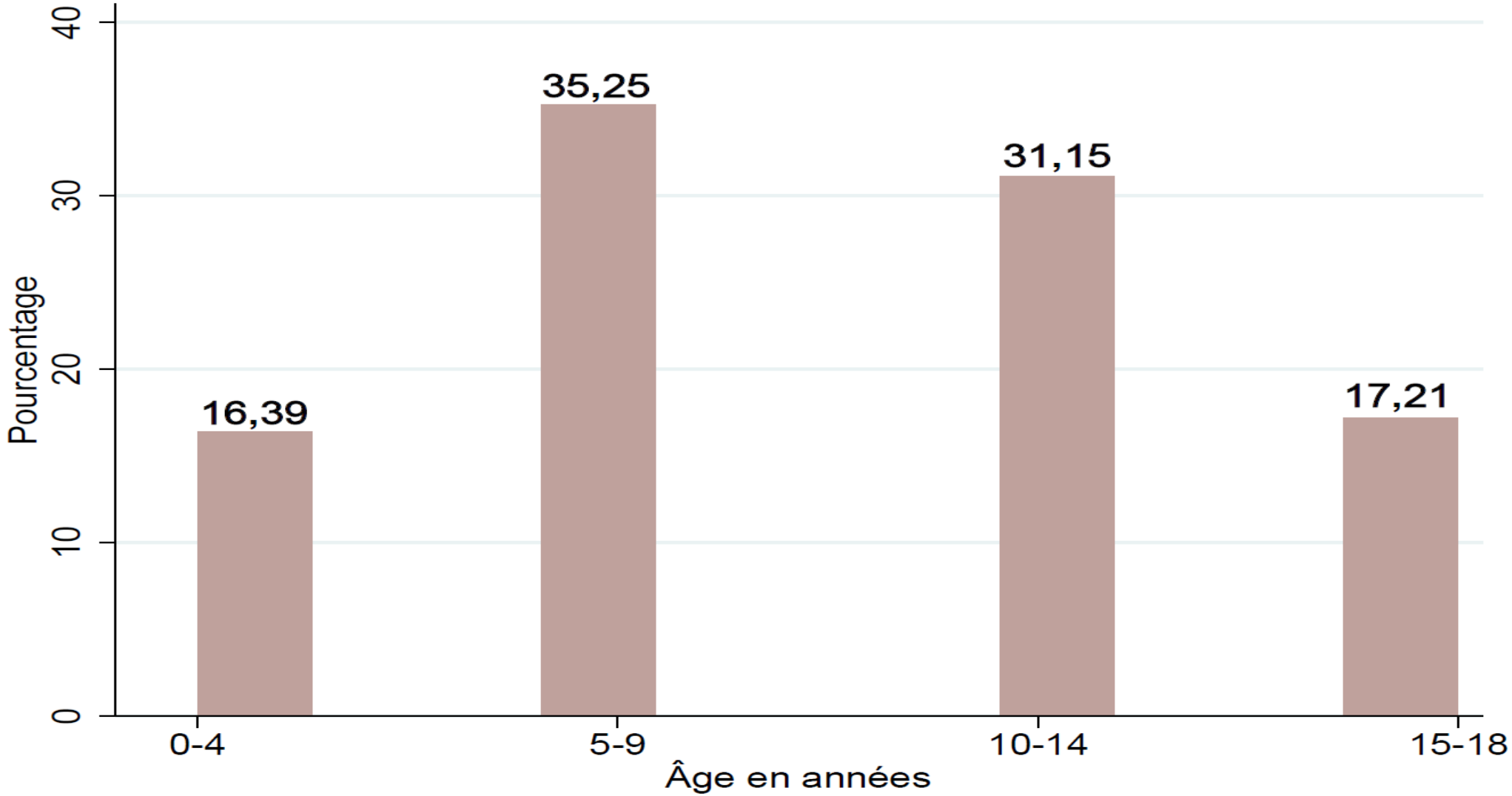

Figure 1 : Distribution de notre population d'étude selon l'âge.

Résultats

Tableau I : Principales indications de l'EEG portées sur les bulletins.

Indications de l'EEG	Effectif	Pourcentage
Crises généralisées tonicocloniques	29	23,4
Epilepsie	14	11,3
Perte de connaissance	13	10,5
Crises tonicocloniques	12	9,7
Absences	7	5,6
Crises toniques	7	5,6
Crises focales	6	4,8
Convulsions	6	4,8
Retard psychomoteur	6	4,8

Résultats

Confirmation de l'épilepsie :

- Globalement : 70,9 %
- EEG de sommeil : 81,8 %
- EEG de veille : 62,3 %.

Résultats

Tableau II : Principaux syndromes épileptiques trouvés.

Syndromes	Effectif	Pourcentage
Epilepsie focale	26	29,5
Epilepsie focale secondairement généralisée	22	25
Epilepsie généralisée	16	18,2
Epilepsie à pointes centro-temporales	10	11,4
Epilepsie absence	6	6,8
Encéphalopathie épileptique	5	5,7
Syndrome de West	2	2,3
Syndrome de Lennox Gastaut	1	1,1

Résultats

Tableau III : Facteurs associés à la positivité de l'EEG (analyse uni variée).

Facteurs	OR	IC95 %	p
Type d'EEG			**0,01**
Veille	1		
Sommeil	2,72	1,17-6,30	
Demandeur			**<0,001**
Spécialiste	4,1	1,7-10,7	
Autres	1		

Résultats

Tableau III : Facteurs associés à la positivité de l'EEG (analyse multivariée).

Facteurs	OR	IC95 %	p
Type d'EEG			0,11
Veille	1		
Sommeil	2,02	0,83-4,91	
Demandeur			**0,005**
Spécialiste	3,57	1,47-9,09	
Autres	1		

Conclusion

- Rôle de l'EEG capital en épileptologie, dans la confirmation diagnostique, dans la classification syndromique et dans l'instauration et la surveillance du traitement.
- Confirmation de l'épilepsie par l'EEG dans cette étude dans 70,9 % des cas.

Conclusion

- Association significative à la positivité de l'EEG et la demande faite par un médecin spécialiste,
- Nécessité de renforcer les compétences des agents de santé sur le diagnostic de l'épilepsie ainsi que les indications de l'EEG.
- Etudes prospectives sur la positivité de l'EEG selon le type d'épilepsie

Merci pour votre attention